CAC
Cuenta de Alto Costo

7

Cáncer de pulmón

RESUMEN infográfico

Cáncer de pulmón

7

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

Morbimortalidad del cáncer de pulmón



Ocupó el **séptimo lugar** en frecuencia entre los 11 tipos de cáncer priorizados en el país.



El número total de casos nuevos, prevalentes y fallecidos en el **periodo** fue de 1.518, 7.276 y 1.781, respectivamente.



Comparativamente con el periodo anterior, **la prevalencia** aumentó en 1,23 casos por 100.000 habitantes, la PCNR aumentó en 0,14 y la mortalidad aumentó en 0,05 por 100.000 habitantes.

Se registraron 1.772 muertes entre las personas con cáncer invasivo, lo que representa una mortalidad general estandarizada de 2,80 fallecimientos por 100.000 habitantes (IC 95 %: 2,67 - 2,94).

Caracterización de los casos nuevos de cáncer de pulmón

La mediana de la edad fue de 70 años (RIC: 63 - 76).

Más de la mitad de los casos correspondió al sexo masculino (52,64 %).

El 99,93 % correspondió a neoplasias invasivas; esta proporción fue de 100,00 % en los regímenes subsidiado y de excepción.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de cáncer de pulmón

La proporción nacional de casos diagnosticados en estadios tempranos (I-II) fue de 14,87 % en 2025, manteniéndose por debajo de la meta establecida (20 %).

El tiempo promedio para el **inicio del tratamiento** fue de 50,75 días, también por encima de la meta establecida (30 días).

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
RIC: rango intercuartílico.

7. Cáncer de pulmón

CIE10: C33-C34; D02.1-D02.2; CIE-O-3: C33-C34

7.1. Morbimortalidad del cáncer de pulmón

En cuanto a los casos nuevos, el cáncer de pulmón ocupó el séptimo lugar entre los 11 tipos de cáncer priorizados. Para el año 2025, se reportaron 7.276 casos prevalentes, incluidos los carcinomas *in situ* y los tumores invasivos; de estos, 1.518 (20,86 %) fueron diagnosticados durante el periodo de análisis. En relación con la mortalidad, se registraron 1.781 muertes por todas las causas en esta población. Cabe señalar que las medidas de morbimortalidad fueron calculadas incluyendo únicamente los casos invasivos **(tabla 7.1).**

Tabla 7.1. Medidas de frecuencia del cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Indicador	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida estandarizada[2,4]	IC 95 %[5]
PCNR	1.517	2,88	2,43	(2,31 - 2,56)
Prevalencia	7.168	13,62	11,51	(11,25 - 11,78)
Mortalidad[6]	1.772	3,37	2,80	(2,67 - 2,94)

[1] Incluye todos los casos de cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informadas por 100.000 habitantes.
[3] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

7.1.1. PCNR de cáncer de pulmón según la región y la entidad territorial

La mayor PCNR estandarizada de cáncer de pulmón se observó en Bogotá, D. C., con 3,16 casos por 100.000 habitantes (IC 95 %: 2,21 - 3,54). En contraste, la región Amazonía-Orinoquía presentó la más baja, con 0,99 (IC 95 %: 0,51 - 1,71) **(tabla 7.2).**

En los territorios, la PCNR estandarizada mostró un valor más elevado en Antioquia (3,74) y La Guajira (3,60), mientras que las más bajas se observaron en Arauca (0,38), Cauca (0,57) y Tolima (0,80). Los departamentos del Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no reportaron casos nuevos durante el periodo analizado.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 7.2. PCNR de cáncer de pulmón según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	12	1.544.639	0,78	0,99	(0,51 - 1,71)
Bogotá, D. C.	305	7.918.660	3,85	3,16	(2,81 - 3,54)
Caribe	293	12.130.521	2,42	2,44	(2,17 - 2,74)
Central	479	12.486.760	3,84	2,87	(2,62 - 3,14)
Oriental	232	9.966.135	2,33	1,95	(1,70 - 2,22)
Pacífica	196	8.567.038	2,29	1,80	(1,55 - 2,07)
Nacional	**1.517**	**52.613.753**	**2,88**	**2,43**	**(2,31 - 2,56)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] Informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

7.1.2. PCNR de cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

La PCNR estandarizada de cáncer de pulmón fue similar entre los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción. Por su parte, en el régimen especial se presentó un valor más bajo, con menos de 1 caso por 100.000 afiliados (IC 95 %: 0,01 - 28,69) **(tabla 7.3).**

Según las entidades aseguradoras, las mayores PCNR se registraron en la EAS016 (10,93) y la RES002 (5,38). Por el contrario, las más bajas se observaron en la ESS062 (0,05), la EPSI01 (0,39) y la EPSI05 (0,47). La EPS047, la EPSI03 y la EPSI06 no reportaron casos nuevos durante el periodo.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 7.3. PCNR de cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	904	28.511.097	3,17	2,40	(2,24 - 2,56)
Subsidiado	532	20.558.122	2,59	2,01	(1,84 - 2,20)
Excepción	80	2.096.836	3,82	2,17	(1,71 - 2,74)
Especial	1	40.687	2,46	0,30	(0,01 - 28,69)
No asegurados	0	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] Informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

7.1.3. Prevalencia del cáncer de pulmón según la región y la entidad territorial

La región Central presentó la prevalencia estandarizada más alta, seguida de Bogotá, D. C., mientras que la menor se observó en la región Amazonía-Orinoquía, con 4,83 casos por 100.000 habitantes **(tabla 7.4).** En los entes territoriales, Antioquía presentó la mayor prevalencia con 21,61 (IC 95 %: 20,65 - 22,61); en contraste, la más baja fue estimada en el Guaviare con 1,19 (IC 95 %: 0,03 - 7,13). En los departamentos del Vaupés y Vichada no se reportaron casos prevalentes con esta neoplasia durante el periodo analizado.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 7.4. Prevalencia del cáncer de pulmón según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	59	1.544.639	3,82	4,83	(3,67 - 6,22)
Bogotá, D. C.	1.479	7.918.660	18,68	15,39	(14,61 - 16,20)
Caribe	1.054	12.130.521	8,69	8,80	(8,28 - 9,35)
Central	2.623	12.486.760	21,01	15,76	(15,16 - 16,38)
Oriental	922	9.966.135	9,25	7,77	(7,28 - 8,30)
Pacífica	1.031	8.567.038	12,03	9,61	(9,02 - 10,22)
Nacional	**7.168**	**52.613.753**	**13,62**	**11,51**	**(11,25 - 11,78)**

[1] Incluye todos los casos de cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La prevalencia es Informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

7.1.4. Prevalencia del cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Según el régimen del aseguramiento, la prevalencia estandarizada del cáncer de pulmón fue mayor en el régimen especial **(tabla 7.5).** Asimismo, en el contributivo se presentaron 1,89 veces más casos que en el subsidiado. Por su lado, al analizar por las entidades aseguradoras, la prevalencia más alta fue la estimada en la EAS016, entidad del contributivo, con 59,18 casos prevalentes (IC 95 %: 24,34 - 726,07). En contraste, la menor prevalencia se presentó en la EPSI03 con 1,17 (IC 95 %: 0,43 - 2,53), entidad específica para la atención de población indígena. Para el periodo de análisis, la EPS047 no reportó casos de esta neoplasia.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 7.5. Prevalencia del cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	4.830	28.511.097	16,94	12,86	(12,50 - 13,23)
Subsidiado	1.783	20.558.122	8,67	6,80	(6,48 - 7,12)
Excepción	433	2.096.836	20,65	11,70	(10,60 - 12,91)
Especial	28	40.687	68,82	14,04	(7,67 - 40,42)
No asegurado	19	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	3	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	72	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de cáncer del pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

7.1.5. Mortalidad en las personas con cáncer de pulmón según la región y la entidad territorial

En la cohorte en seguimiento, la mortalidad general estandarizada para cáncer de pulmón fue menor en Amazonía–Orinoquía, mientras que, la más alta se observó en la región Central **(tabla 7.6).** Esto representa una diferencia absoluta de 2,20 muertes por todas las causas por 100.000 habitantes, entre estas dos regiones.

En los departamentos, la cifra más baja se encontró en Casanare con 0,84 (IC 95 %: 0,17 – 2,36). En contraste, la más alta fue en Guainía con 6,17 (IC 95 %: 0,74 – 20,74). Los departamentos del Amazonas, Guaviare, Vaupés y Vichada no reportaron fallecimientos en personas con cáncer de pulmón durante el periodo analizado.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 7.6. Mortalidad general del cáncer de pulmón según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	18	1.544.639	1,17	1,50	(0,89 - 2,35)
Bogotá, D. C.	316	7.918.660	3,99	3,25	(2,90 - 3,63)
Caribe	313	12.130.521	2,58	2,60	(2,32 - 2,90)
Central	626	12.486.760	5,01	3,70	(3,41 - 4,00)
Oriental	238	9.966.135	2,39	1,97	(1,73 - 2,24)
Pacífica	261	8.567.038	3,05	2,35	(2,07 - 2,66)
Nacional	**1.772**	**52.613.753**	**3,37**	**2,80**	**(2,67 - 2,94)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

7.1.6. Mortalidad del cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

El régimen subsidiado presentó la mortalidad general estandarizada más baja en comparación con el contributivo **(tabla 7.7).** En cuanto a las entidades, la EAPB con la menor cifra fue la ESS062 con 0,26 muertes por 100.000 afiliados (IC 95 %: 0,08 - 0,64), mientras que la EAS016 tuvo el mayor valor con 12,16 muertes por 100.000 afiliados (IC 95 %: 3,87 - 700,03).

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 7.7. Mortalidad general del cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

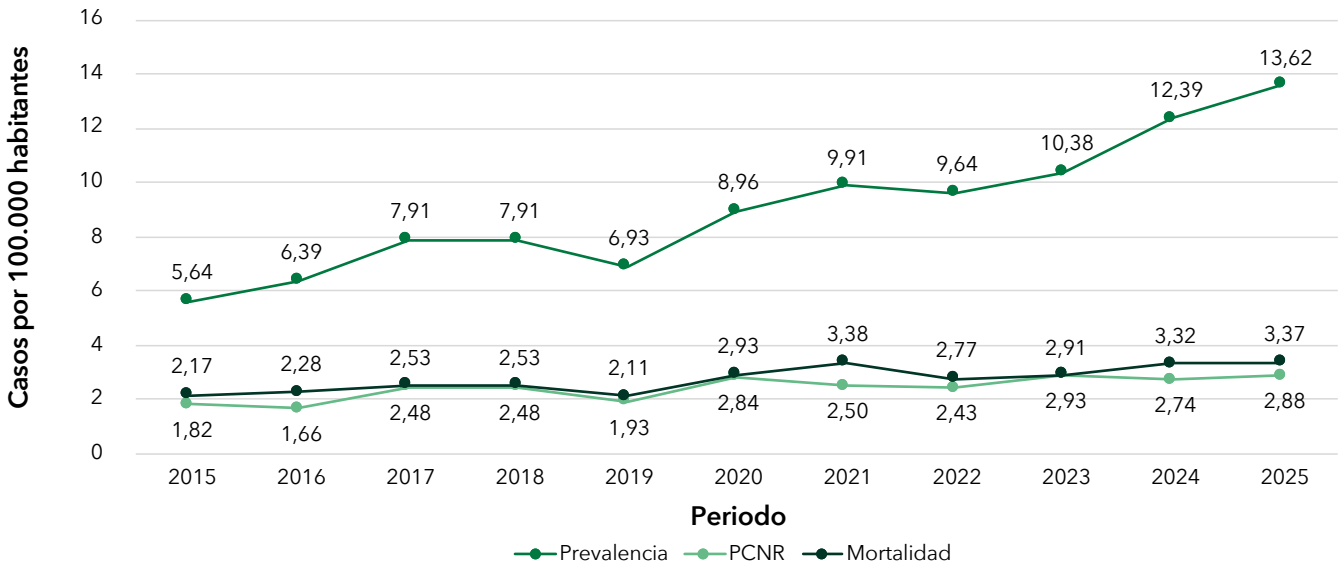
Régimen	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	1.058	28.511.097	3,71	2,76	(2,60 - 2,94)
Subsidiado	638	20.558.122	3,10	2,38	(2,20 - 2,57)
Excepción	62	2.096.836	2,96	1,63	(1,24 - 2,13)
Especial	0	40.687	0,00	NA	NA
No asegurado	0	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	14	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato; **NA:** no aplica.

7.1.7. Evolución del registro de cáncer de pulmón en el aseguramiento en Colombia

La **figura 7.1** presenta la tendencia de la morbimortalidad por cáncer de pulmón en el país. Durante el seguimiento de la cohorte, la prevalencia mostró un incremento progresivo, con un aumento de 1,23 casos por 100.000 habitantes para el 2025, con respecto al periodo anterior. Del mismo modo, la PCNR evidenció un incremento leve de 0,14 casos por 100.000 habitantes, mientras que la mortalidad presentó una variación mínima de 0,05 muertes por 100.000 habitantes, y se mantuvo superior a la PCNR calculada para el periodo 2025.

Figura 7.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2015 - 2025



Incluye los casos con cáncer de pulmón invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por 100.000 habitantes.
Mortalidad: número de casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

Descargar figura

7.2. Caracterización de los casos nuevos de cáncer de pulmón

7.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de cáncer de pulmón

La **tabla 7.8** presenta la caracterización general de los casos nuevos de cáncer de pulmón reportados en el periodo. Según el régimen del aseguramiento, el 59,62 % de los casos correspondió a población afiliada al régimen contributivo. En general, la distribución de los casos fue similar entre hombres y mujeres. Asimismo, la mediana de edad fue de 70 años (RIC: 63 - 76), lo cual fue consistente entre los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción.

En cuanto a la etnia, aunque la mayoría de los casos fueron clasificados en la categoría ninguna, el 1,51 % correspondió a población negra, concentrándose principalmente en el contributivo. Por su parte, la población indígena representó el 0,72 % de los casos, con mayor frecuencia en el subsidiado.

Por región de residencia, se presentó una alta concentración de casos en la Central (31,55 %); este comportamiento fue similar en los regímenes contributivo, de excepción y especial. No obstante, en el subsidiado la mayoría de los casos se concentró en la región Caribe. A su vez, los casos diagnosticados durante el periodo en la Amazonía-Orinoquía se ubicaron en su mayoría en el subsidiado.

Tabla 7.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos reportados de cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 905	n= 532	n= 80	n= 1.518
	(59,62 %)	(35,05 %)	(5,27 %)	(100,00 %)
Sexo				
Femenino	442 (48,84)	242 (45,49)	35 (43,75)	719 (47,36)
Masculino	463 (51,16)	290 (54,51)	45 (56,25)	799 (52,64)
Edad	70 (63 - 76)	69 (63 - 76)	70 (66 - 76)	70 (63 - 76)
Etnia				
Ninguna	886 (97,90)	515 (96,80)	77 (96,25)	1.479 (97,43)
Negro	12 (1,33)	8 (1,50)	3 (3,75)	23 (1,51)
Indígena	2 (0,22)	9 (1,69)	0 (0,00)	11 (0,72)
Otro[3]	5 (0,55)	0 (0,00)	0 (0,00)	5 (0,33)
Región de residencia				
Amazonía-Orinoquía	1 (0,11)	11 (2,07)	0 (0,00)	12 (0,79)
Bogotá, D. C.	245 (27,07)	37 (6,96)	23 (28,75)	305 (20,09)
Caribe	79 (8,73)	204 (38,35)	10 (12,50)	293 (19,30)
Central	326 (36,02)	125 (23,50)	27 (33,75)	479 (31,55)
Oriental	133 (14,70)	81 (15,23)	18 (22,50)	232 (15,28)
Pacífica	121 (13,37)	74 (13,91)	2 (2,50)	197 (12,98)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad, para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tiene en cuenta un caso del régimen especial.
[3] Incluye a la población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

7.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos reportados de cáncer de pulmón

La **tabla 7.9** describe las características clínicas de los casos nuevos de cáncer de pulmón según su afiliación al sistema de salud. Según la clasificación CIE-10, casi la totalidad de las neoplasias de pulmón correspondió a tumores invasivos; únicamente se identificó un caso *in situ* dentro del régimen contributivo.

La estadificación según la clasificación TNM se realizó en el 82,87 % de los casos, esta proporción fue similar entre los regímenes subsidiado y contributivo, aunque ligeramente mayor en este último. Al momento del diagnóstico, la mayoría de los casos se clasificó en estadio IV, seguido del estadio III, concentrando en conjunto el 86,20 % del total de los CN; este patrón fue consistente en todos los regímenes de afiliación.

Tabla 7.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de pulmón reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 905	n= 532	n= 80	n= 1.518
	(59,62 %)	(35,05 %)	(5,27 %)	(100,00 %)
Extensión[3]				
In situ	1 (0,11)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (0,07)
Invasivo	904 (99,89)	532 (100,00)	80 (100,00)	1.517 (99,93)
Estadificación (sí)[4]	757 (83,65)	430 (80,83)	70 (87,50)	1.258 (82,87)
Estadio al diagnóstico[4,5]				
In situ	1 (0,13)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (0,08)
Estadio I	71 (9,38)	14 (3,26)	10 (14,29)	95 (7,55)
Estadio II	55 (7,27)	18 (4,19)	5 (7,14)	78 (6,20)
Estadio III	116 (15,32)	82 (19,07)	9 (12,86)	207 (16,45)
Estadio IV	514 (67,90)	316 (73,49)	46 (65,71)	877 (69,71)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta un caso en el régimen especial.
[3] Definida según el código CIE-10.
[4] Definida según la clasificación TNM.
[5] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de pulmón que fueron estadificados.

7.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de pulmón

Durante el periodo, 1.011 casos nuevos de cáncer de pulmón (66,60 %) recibieron al menos un manejo terapéutico, dentro de los cuales el 72,21 % correspondió a terapias sistémicas, seguido del manejo quirúrgico (28,59 %) y finalmente la radioterapia (27,00 %). Cabe destacar que, dado que un mismo caso pudo recibir más de una modalidad terapéutica, los porcentajes de la **tabla 7.10** no son mutuamente excluyentes.

Según el estadio clínico al diagnóstico, en los estadios II, III y IV la terapia sistémica fue la más frecuentemente usada. A su vez, el tratamiento quirúrgico predominó en los casos nuevos *in situ*, en el estadio I y en aquellos con estadio clínico desconocido. También se encontró que de los siete casos que recibieron terapia sistémica, seis tuvieron cirugía previamente.

Entre los casos diagnosticados en estadio IV que recibieron manejo quirúrgico, la mayoría de los procedimientos reportados correspondieron a resecciones o extirpaciones de tumores, lóbulos pulmonares o tejido pleural, mientras que solo dos casos registraron una resección de lesión bronquial por vía endoscópica (CUPS 320201). Por otro lado, la radioterapia se utilizó con mayor frecuencia en el estadio IV en comparación con los demás estadios.

Por otro lado, 507 casos no habían recibido tratamiento al corte del periodo de análisis. De estos, 186 (36,69 %) registraron al menos una valoración por cuidados paliativos.

Se identificaron 213 casos (42,01 %) que fallecieron dentro de los 90 días posteriores al diagnóstico. De estos, 148 contaban con información sobre la fecha de remisión y la fecha de diagnóstico, observándose una mediana de tiempo al diagnóstico de 20 días (RIC: 14 - 34).

En cuanto a la estadificación de estos casos la mayor proporción de fallecimientos se observó en los casos diagnosticados en estadio IV (49,77 %; n= 106), seguida de aquellos con estadio clínico desconocido (41,31 %; n= 88). Los estadios III, II y I representaron el 6,10 % (n= 13), 2,35 % (n= 5) y 0,47 % (n= 1), respectivamente.

Tabla 7.10. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de cáncer de pulmón según el estadio clínico, Colombia 2025

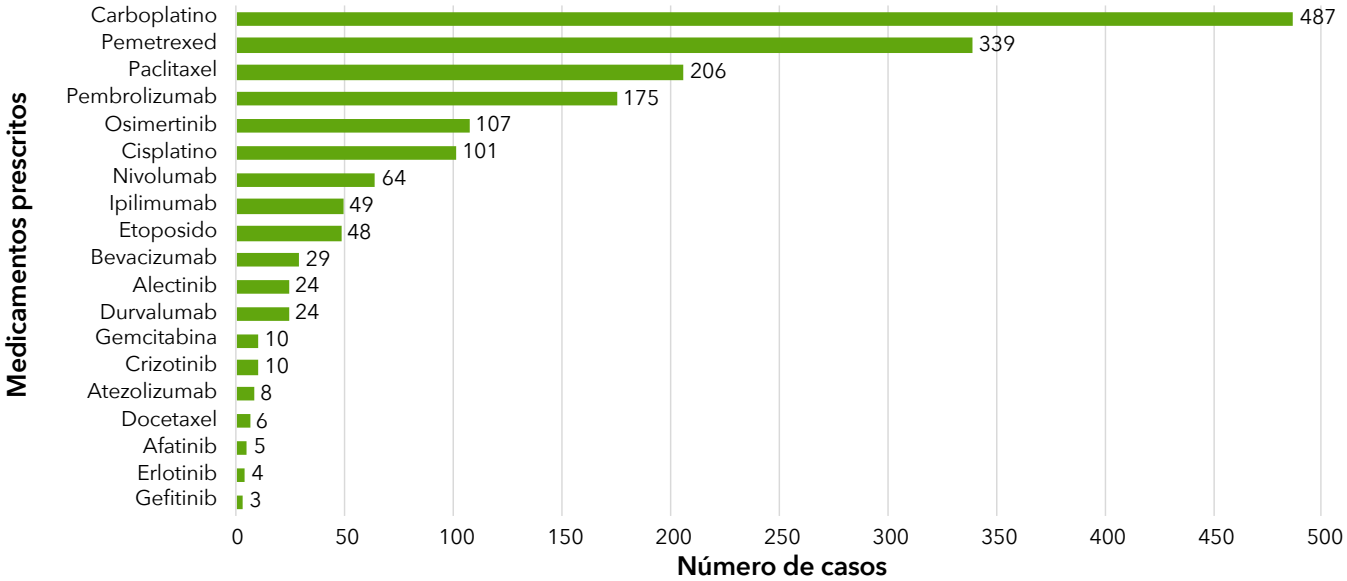
Variables[1]	Estadio al diagnóstico						
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	Total
	n= 1	n= 95	n= 78	n= 207	n= 877	n= 260	n= 1.518
	(0,07 %)	(6,26 %)	(5,14 %)	(13,64 %)	(57,57 %)	(17,13 %)	(100,00 %)
Casos que recibieron algún tratamiento	1 (100,00)	76 (80,00)	57 (73,08)	158 (76,33)	627 (71,49)	92 (35,38)	1.011 (66,60)
Tipo de tratamiento prescrito[2]							
Terapia sistémica[3]	0 (0,00)	7 (9,21)	47 (82,46)	136 (86,03)	506 (80,70)	34 (39,96)	730 (72,21)
Cirugía	1 (100,00)	70 (92,11)	30 (52,63)	43 (27,22)	86 (13,72)	59 (64,13)	289 (28,59)
Radioterapia	0 (0,00)	7 (9,21)	3 (5,26)	38 (24,05)	214 (34,13)	11 (11,96)	273 (27,00)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de pulmón que fueron reportados a la CAC durante el periodo.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

A continuación, la **figura 7.2** presenta los medicamentos prescritos para el manejo del cáncer de pulmón. Para su interpretación, debe tenerse en cuenta que los datos corresponden a frecuencias absolutas de prescripción, es decir que no discriminan el uso concomitante de uno o más fármacos. Por lo tanto, no permiten inferir esquemas completos, líneas de tratamiento, ni combinaciones terapéuticas.

Los medicamentos más utilizados, después del carboplatino, fueron, el pemetrexed y el paclitaxel, agentes citotóxicos que hacen parte de esquemas de quimioterapia basada en platino, cuya selección se relaciona, entre otros factores, con el tipo histológico.

Figura 7.2. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo, en todas las edades.

Descargar figura

7.3. Caracterización de los casos prevalentes de cáncer de pulmón

La **tabla 7.11** presenta las características demográficas de los casos prevalentes de cáncer de pulmón reportados en el periodo (incluyendo a los tumores *in situ* e invasivos), según el régimen del aseguramiento. La distribución por sexo fue similar entre regímenes; al menos la mitad de los casos prevalentes fueron mujeres. No obstante, en la población no asegurada predominaron los casos en hombres. La mediana de edad fue de 70 años (RIC: 62 - 77), pero fue más alta en el régimen especial.

Aunque el 98,00 % de los casos prevalentes no reportó pertenecer a un grupo étnico, se observaron diferencias por régimen del aseguramiento. Particularmente, el régimen contributivo presentó un mayor número de casos de personas de etnia negra. Por su parte, la población indígena concentró más casos en el régimen subsidiado.

Según la región de residencia, el 36,50 % de los casos se ubicó en la región Central, patrón que fue similar entre los regímenes del aseguramiento, con excepción del subsidiado, en donde el 32,64 % se concentró en la región Caribe. El número de casos que residen en la región Amazonía-Orinoquía fue menor en comparación con el resto de los territorios.

Tabla 7.11. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de cáncer de pulmón según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento					
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	No asegurado	Total[2,3]
	n= 4.891	n= 1.817	n= 438	n= 29	n= 19	n= 7.203
	(67,99 %)	(23,23 %)	(6,08 %)	(0,40 %)	(0,26 %)	(100,00 %)
Sexo						
Femenino	2.839 (57,97)	910 (50,08)	234 (53,42)	19 (65,52)	4 (21,05)	4.006 (55,62)
Masculino	2.058 (42,03)	907 (49,92)	204 (46,58)	10 (34,48)	15 (78,95)	3.197 (44,38)
Edad	70 (62 - 77)	69 (62 - 76)	72 (66 - 78)	80 (75 - 86)	68 (59 - 75)	70 (62 - 77)
Etnia						
Ninguna	4.827 (98,57)	1.750 (96,31)	431 (98,40)	29 (100,00)	19 (100,00)	7.059 (98,00)
Negro	53 (1,08)	31 (1,71)	7 (1,60)	0 (0,00)	0 (0,00)	91 (1,26)
Indígena	8 (0,16)	36 (1,98)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	44 (0,61)
Otro[4]	9 (0,18)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	9 (0,12)
Región de residencia						
Amazonía-Orinoquía	16 (0,33)	52 (2,86)	3 (0,68)	0 (0,00)	0 (0,00)	71 (0,99)
Bogotá, D. C.	1.209 (24,69)	150 (8,26)	108 (24,66)	1 (3,45)	2 (10,53)	1.472 (20,44)
Caribe	383 (7,82)	593 (32,64)	81 (18,49)	1 (3,45)	1 (5,26)	1.059 (14,70)
Central	1.927 (39,35)	539 (29,66)	140 (31,96)	17 (58,62)	6 (31,58)	2.629 (36,50)
Oriental	619 (12,64)	232 (12,77)	73 (16,67)	3 (10,34)	6 (31,58)	934 (12,97)
Pacífica	743 (15,17)	251 (13,81)	33 (7,53)	7 (24,14)	4 (21,05)	1.038 (14,41)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n,%) para todas las variables, excepto la edad, para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta tres casos reportados por los planes voluntarios de salud.
[3] No se incluyeron los datos de 73 casos prevalentes que no se reportaron en el periodo actual porque pertenecen a entidades liquidadas.
[4] Incluye a la población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenqueros de San Basilio.

7.4. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de pulmón

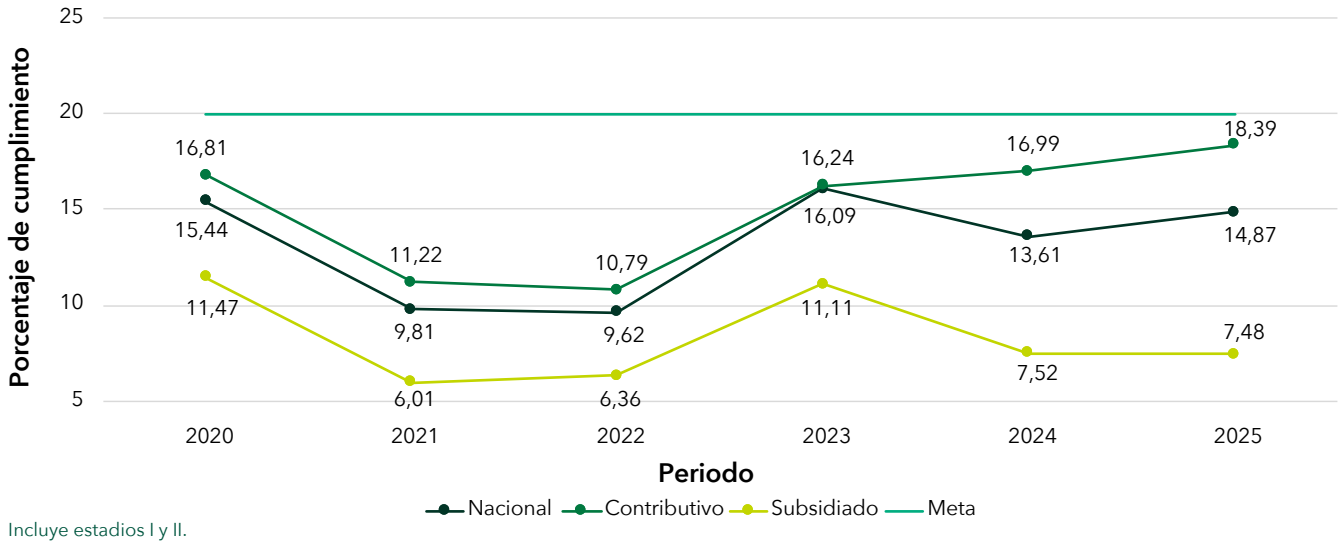
Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, evaluación y monitoreo de la gestión del riesgo por parte de aseguradores y prestadores en las personas con cáncer de pulmón en Colombia (1):

1. Oportunidad de diagnóstico (tiempo desde la consulta general o nota de remisión o interconsulta o sospecha clínica o paraclínica hasta el diagnóstico de cáncer de pulmón).
2. Proporción de pacientes con estudio morfológico e inmunológico completo (estudio en biopsia de pulmón).
3. Proporción de personas con cáncer de pulmón de célula no pequeña subtipo histológico adenocarcinoma en estadio IIIB y IV en quienes se realizó el biomarcador EGFR.
4. Proporción de pacientes con cáncer de pulmón diagnosticados en estadios tempranos (IA - IB, IIA - IIB).
5.1. Proporción de pacientes con cáncer de pulmón en quienes se realizó estadificación TNM previo al inicio del tratamiento, CNR.
6.1. Proporción de los pacientes en estadios tempranos (I - II) llevados a cirugía con intención curativa en quienes se realizó el estudio de función pulmonar y riesgo cardiovascular, CNR.
6.2. Proporción de los pacientes en estadios tempranos (I - II) llevados a cirugía con intención curativa en quienes se realizó el estudio de función pulmonar y riesgo cardiovascular, prevalentes.
7. Oportunidad de tratamiento (promedio de días entre el diagnóstico y el primer tratamiento).
8. Proporción de pacientes en estadios tempranos (I - II) que fueron sometidos a cirugía con intención curativa.
9.1. Proporción de pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en estadio avanzado (IV) valorados por cuidado paliativo (CNR).
9.2. Proporción de pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en estadio avanzado (IV) valorados por cuidado paliativo (prevalentes).
10.1. Proporción de personas atendidas por grupo multidisciplinario para definir el tratamiento (CNR).
10.2. Proporción de personas atendidas por grupo multidisciplinario para definir el tratamiento, (prevalentes).
11. Supervivencia a 1 año y 2 años (tipo histológico: CPCP).
12. Supervivencia a 2 años y 5 años (tipo histológico: CPCNP).

Según la periodicidad establecida, se presentaron resultados para el periodo 2024 de los indicadores 11 y 12 en un informe especial.

La proporción de casos en estadios tempranos al momento del diagnóstico del cáncer de pulmón entre 2020 y 2025 se mantuvo consistentemente por debajo de la meta establecida (< 20 %). En este periodo, el régimen contributivo presentó la mayor proporción alcanzando su valor más alto en 2025 (18,39 %). Por su parte, el subsidiado mostró una proporción menor (7,48 % en 2025), con una disminución de 0,04 % respecto al 2024. En consecuencia, se evidencia una brecha de 10,91 puntos porcentuales entre ambos regímenes.

Figura 7.3. Tendencia de la proporción de los casos nuevos en estadios tempranos en el momento del diagnóstico en cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 – 2025

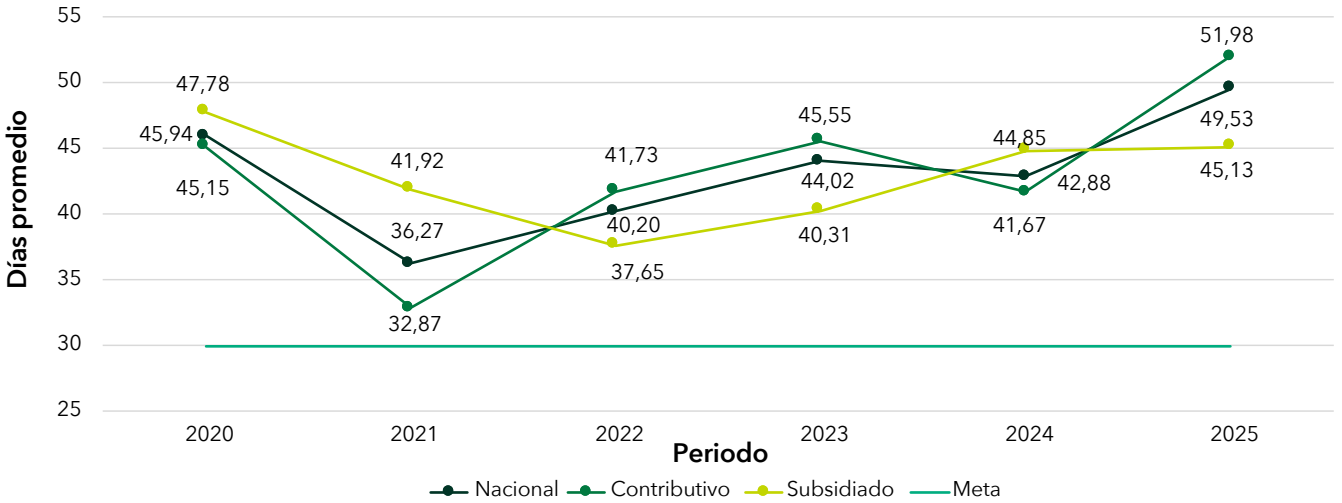


Incluye estadios I y II.

Descargar figura

En promedio, un caso de cáncer de pulmón tardó 49,53 días en recibir confirmación diagnóstica tras la consulta o la remisión. El mayor tiempo se registró en el régimen contributivo con 51,98 días. La tendencia observada durante los últimos cinco periodos evidencia un incremento en el tiempo de la oportunidad de la confirmación diagnóstica, con una brecha entre los regímenes de afiliación en el último periodo. Cabe resaltar que el régimen subsidiado presentó una mayor proporción de casos diagnosticados en estadios avanzados. Esta diferencia podría contribuir a explicar el menor tiempo hasta la confirmación diagnóstica en este régimen, ya que las manifestaciones clínicas de la enfermedad avanzada suelen ser más evidentes, lo que favorece la sospecha clínica y la realización oportuna de las pruebas diagnósticas confirmatorias.

Figura 7.4. Tendencia de la oportunidad de la confirmación diagnóstica de los casos nuevos de cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025

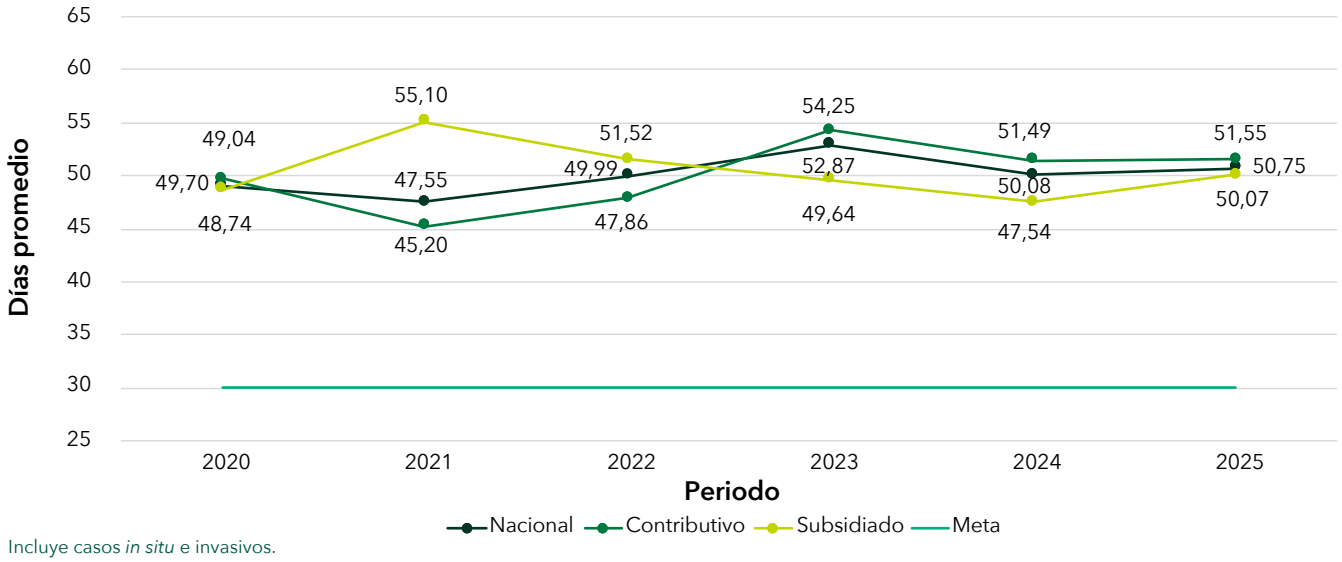


Incluye casos *in situ* e invasivos.
Tiempo transcurrido desde la consulta o remisión hasta la confirmación diagnóstica.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 49,53 días (± 65,87) en la medición nacional, de 51,98 días (± 67,03) en el régimen contributivo y de 45,13 días (± 63,80) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 26 días (RIC: 14 - 60) en la medición nacional, de 28 días (RIC: 15 - 63) en el régimen contributivo y de 23 días (RIC: 13 - 47) en el subsidiado.

Descargar figura

El tiempo para iniciar el tratamiento se mantiene por encima a los 30 días, tanto en el país como en la medición por régimen del aseguramiento. En el último periodo se observa una disminución en la brecha entre los regímenes, la cual corresponde a 1,48 días promedio.

Figura 7.5. Tendencia de la oportunidad del inicio del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de pulmón en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



Incluye casos *in situ* e invasivos.
Tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento.
La media (desviación estándar) para la oportunidad de inicio del tratamiento en el 2025 fue: de 50,75 días (± 45,07) en la medición nacional, de 51,55 días (± 47,00) en el régimen contributivo y de 50,07 días (± 42,71) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad de inicio del tratamiento en el 2025 fue: de 39,50 días (RIC: 17 - 71) en la medición nacional, de 40 días (RIC: 18 - 74) en el régimen contributivo y de 40 días (RIC: 16 - 75) en el subsidiado.

Descargar figura

La proporción de casos nuevos con estudio morfológico e inmunológico completo presentó el mayor resultado en Bogotá, D. C., con 56,66 %. En contraste, la región con menor proporción fue la Central, con una diferencia de 11,17 puntos porcentuales frente a Bogotá, D. C.

En cuanto a los casos de cáncer de pulmón de célula no pequeña, subtipo adenocarcinoma, en estadios IIIB - IV con realización de EGFR, el cumplimiento fue inferior al 70 %, tanto en el país como en todas las regiones, lo que corresponde a un bajo desempeño del indicador. Por otro lado, la estadificación TNM antes del inicio del tratamiento se realizó en al menos el 55 % de los casos nuevos reportados en el país; se resalta el resultado de la región Caribe, la cual presentó el mayor cumplimiento, con 59,59 %.

Respecto a la evaluación prequirúrgica en los casos nuevos en estadios I - II, mediante prueba de función pulmonar y valoración del riesgo cardiovascular antes de la cirugía, la región Central alcanzó el mayor resultado, con el 39,02 %. En la Amazonía-Orinoquía no se reportaron casos para este indicador. Por su parte, en los casos prevalentes el cumplimiento fue menor, con un resultado nacional de 16,33 %.

Tabla 7.12. Indicadores de la gestión del riesgo en el cáncer de pulmón según la región de residencia, Colombia 2025

Número		1.	2.	3.	4.	5.1.	6.1.	6.2.
Código[1]		PUL_01	PUL_02	PUL_03	PUL_04	PUL_05_1	PUL_06_1	PUL_06_2
Semaforización		< 30 días ≥ 30 a < 60 días ≥ 60 días	Por definir	> 90 % > 70 a ≤ 90 % ≤ 70 %	> 20 % > 14 a ≤ 20 % ≤ 14 %	> 90 % > 70 a ≤ 90 % ≤ 70 %	Por definir	Por definir
Región	Amazonía-Orinoquía	24,63	47,06	20,00	0,00	50,00	SD	SD
	Bogotá, D. C.	47,13	56,66	57,25	21,74	53,00	0,00	5,26
	Caribe	49,11	46,32	43,00	12,60	59,59	6,67	6,25
	Central	52,73	45,49	52,05	16,39	55,78	39,02	26,23
	Oriental	52,01	50,00	31,00	9,24	58,20	12,50	7,14
	Pacífica	45,03	48,65	52,50	10,69	50,00	36,36	22,22
Nacional		**49,53**	**48,66**	**47,87**	**14,87**	**55,49**	**22,86**	**16,33**

La proporción de pacientes en estadios tempranos (I - II) sometidos a cirugía con intención curativa (indicador 9) fue inferior al 70 % en el país como en todas las regiones. El valor más cercano a este umbral se observó en la región Pacífica (64,71 %), mientras que la región Oriental presentó la menor proporción (47,06 %), por lo que fue la más alejada del cumplimiento de la meta.

La valoración por cuidado paliativo en los casos nuevos en estadio IV fue mayor que en los casos prevalentes. La región Central registró las proporciones más altas para ambos tipos de casos (68,86 % y 51,07 %, respectivamente), en contraste con la región Oriental, que presentó los valores más bajos (42,45 % y 22,55 %, en ese orden). Aunque no se dispone de una meta establecida para el indicador de atención multidisciplinaria, este evidenció proporciones bajas tanto en los casos nuevos (2,70 %) como en los prevalentes (0,81 %).

Tabla 7.12. Indicadores de la gestión del riesgo en el cáncer de pulmón según la región de residencia, Colombia 2025 (continuación)

Número		7.	8.	9.1.	9.2.	10.1.	10.2.
Código[1]		PUL_07	PUL_08	PUL_09_1	PUL_09_2	PUL_10_1	PUL_10_2
Semaforización		< 30 días ≥ 30 a < 60 días ≥ 60 días	> 90 % > 70 a ≤ 90 % ≤ 70 %	> 90 % > 70 a ≤ 90 % ≤ 70 %	> 90 % > 70 a ≤ 90 % ≤ 70 %	Por definir	Por definir
Región	Amazonía-Orinoquía	66,00	SD	60,00	43,48	0,00	0,00
	Bogotá, D. C.	56,89	54,55	58,58	41,75	1,63	0,50
	Caribe	44,60	48,39	50,88	37,23	2,73	0,88
	Central	47,34	58,57	68,86	51,07	3,97	1,01
	Oriental	55,40	47,06	42,45	25,55	2,58	0,78
	Pacífica	53,81	64,71	61,16	44,86	1,52	0,73
Nacional		**50,75**	**55,26**	**58,09**	**42,45**	**2,70**	**0,81**

[1] Código del indicador en HIGIA.

Referencias bibliográficas

1. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia: Indicadores de gestión del riesgo en pacientes con cáncer de pulmón en Colombia [en línea]. 2018. p. 1-98. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/site/publicaciones/consenso-basado-en-la-evidencia-indicadores-de-gestion-del-riesgo-en-pacientes-con-cancer-de-pulmon-en-colombia/
2. Cuenta de Alto Costo (CAC), Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014-2022; Bogotá, D. C. 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/